EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS
N° EGRESO : 84087
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 08-05-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: BERNARDO SEPULVEDA CONCHA			**RUN**	: 7.972.726-1
F.Nac	: 31-10-1957	**Edad**	: 66 AÑOS, 6 MESES	**Género**	: Masculino
Dirección	: D NAVOTAVO 7			**Comuna**	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	**Teléfono**	: 983921345		
Fecha Ingreso	: 2024-04-25	**Fecha Egreso**	: 08-05-2024	**Causal**	: MEDICA
Condición	: VIVO	**Destino**	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	**Derivación**	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J18.9-NEUMONIA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica, resuelta
- Neumonía multifocal, mayor compromiso a izquierda en tratamiento Klebsiella BLEE
2. Enfermedad arterial oclusiva crónica
- Amputación infracondílea extremidad inferior izquierda (noviembre 2023)
- Usuario de DOAC
3. ACV Secuelado (ACV pontomesencefálico derecho. INO derecho abril/2023)
4. Hipertensión arterial
5. DM2 con complicaciones microvasculares
6. HPB

Ceftriaxona 8 días
Tazonam 4 días
Meropenem 2 días

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J18.0-BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes descritos, consulta en servicio de urgencia de HSC el 24/04/24 por cuadro de 2 días de evolución de CEG, sensación febril, disnea progresiva. A su ingreso normotenso, taquicárdico, taquipneico, con requerimiento de FiO2. Exámenes de laboratorio destaca glicemia 184; crea 0,7; ac úrico 5; calcio 8,2; lactato 1,4; BUN 22, uremia 47; Na/K/Cl 140/3.2/101; Gb 16,2; Hb/Hcto 12.5/36.8; plaq 218000; segmentarios 84%; INR 1,78, dímero D 1075,5, PCR 518. Se realiza AngioTC Tórax: Negativo para TEP, focos de neumonia en ambas bases, ateromatosis aorta torácica. Se inicia manejo con a Ceftriaxona, paciente evoluciona con mayor requerimiento de FiO2, empeoramiento de gasometría. Evaluado por UTI, se decide ingreso para manejo para apoyo con CNAF.
Se inició tto ATB de primera línea con ceftriaxona + azitromicina, previa toma de CSB que da (+) para cándida albicans, panel viral negativo. Con buena respuesta clínica y de laboratorio a tratamiento médico; se mantuvo con CNAF hasta el 27.04 con posterior salida a naricera bajo flujo (FiO2 32%)
Posteriormente se decide egreso y continuidad de tratamiento en servicio de medicina.
Se recibe paciente con persistencia de requerimiento de oxígeno. Parámetros inflamatorios en nuevo ascenso posterior a ingreso a SM, por lo que se decide toma de nuevo CSB además de ajuste de terapia escalada hacia Tazonam del cual recibe 3 días. CSB reporta positivo para

Klebsiella BLEE. En vista de ello, se ajusta terapia con Meropenem (recibiendo al menos durante dos días). Evolución clínca favorable, apoyo con KNT, destete de O2 progresivo hasta resolución de requerimiento el 07/05. En vista de condiciones clínicas actuales se decide derivar Hodom para continuidad de terapia.

INDICACIONES AL ALTA

1. Seguimiento HODOM
2. Reposo relativo
3. Régimen hiposódico - diabético
4. Omeprazol 20mg vo día
5. Cilostazol 100mg vo día
6. Atorvastatina 20mg vo día
7. Pregabalina 75mg vo día
8. Amlodipino 10mg vo día
9. Losartan 50mg vo c12h
10. Tamsulosina 0.4mg vo día
11. Quetiapina 25mg vo día
12. Bromuro ipratropio 4 puff c8h
13. Ertapenem 1gr ev día (Durante 5 días – 0/5)
14. Insulina NPH 24unds am y 14unds sc pm
15. KNT R interdiario
16. Control APS posterior a fin de terapia: Valorar PSCV (metabólico, respiratorio)
17. Valoración y seguimiento nutricional APS
18. Control SU SOS

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO